ALIMENTACIÓN DE PERRO SENIOR

# Cómo alimentar a un perro mayor sin dientes: una guía para el día a día

Por **Equipo Cuida a tu Perro Viejo** · Publicado el 20 de octubre de 2026 · Cómo escribimos

> Qué puede comer un perro mayor sin dientes, cómo elegir y preparar su alimento, medir lo que come y reconocer problemas que requieren atención veterinaria.



*Ilustración generada con IA: beagle senior tricolor, de hocico canoso, ante un plato de comida blanda en una cocina.*

---

📖 **Tabla de Contenidos**

**Un perro mayor sin dientes no necesita automáticamente una papilla ni cambiar toda su dieta.** Primero hay que distinguir si su boca ya está cicatrizada, si acaba de pasar por

una extracción o si tiene dificultades para tragar.

Elegir su comida combina dos decisiones: una base que cubra sus necesidades y una presentación que pueda recoger y comer con comodidad. Estas son las opciones que puedes comentar con su equipo veterinario.

### Qué puede comer

- **Húmedo completo:** si su composición, cantidad y estructura encajan con su estado de salud.
- **Pienso habitual de tamaño adecuado:** puede ser una opción con la boca recuperada y si lo come con comodidad, como explica UC Davis.
- **Su alimento humedecido o triturado:** cuando esa adaptación esté autorizada para el producto y para él.
- **Una receta casera formulada:** con ingredientes, cantidades y preparación indicados por un profesional de nutrición veterinaria.

**ADAPTAR SU COMIDA EMPIEZA POR OBSERVARLO**

Esta guía general, sin un caso clínico concreto, te ayuda a partir de lo que ya tiene indicado: elegir la presentación, preparar su ración y observar cuánto consigue comer. Si acaba de pasar por una extracción, sigue primero las instrucciones del alta.

## Antes del menú: identifica qué parte de comer le cuesta

### No tener dientes no significa no poder comer

Contar las piezas que le quedan dice menos sobre la próxima comida que saber cómo está su boca y qué ocurre al comer. Un perro con extracciones antiguas y revisadas no está en la misma situación que otro con heridas recientes.

La referencia práctica es lo que consigue tomar por sí mismo, sin dificultad, dentro de su plan individual. Si mantiene su dieta habitual con comodidad y su boca está recuperada, puedes centrarte en organizar las tomas y vigilar cambios.

Si perdió dientes sin una evaluación de la boca, o su forma de comer ha cambiado, descríbelo al centro veterinario. Una dificultad nueva merece revisión aunque lleve tiempo sin dientes.

## Coger, masticar y tragar son cosas distintas

Observa la secuencia espontánea: si se acerca, consigue recoger el alimento, lo mantiene en la boca y continúa comiendo. Anota si deja caer porciones, se aparta, mastica de otra manera o interrumpe la toma.

La sección dental de las guías senior de AAHA recomienda examinar la boca ante problemas para coger, masticar o tragar y ante molestias. Lleva esas observaciones a la revisión para valorar qué está dificultando la toma.

Si devuelve alimento o aparece tos durante la toma, cuenta exactamente qué has visto y cuándo ocurrió. No repitas la comida para comprobar si vuelve a pasar ni intentes diferenciar por tu cuenta una enfermedad oral de otra deglutoria.

## Tres situaciones para ordenar el siguiente paso

Esta matriz ordena qué necesitas aclarar al pedir orientación. La revisión veterinaria confirma el estado de la boca y, tras una cirugía, cómo está cicatrizando.

La situación actual decide qué necesitas aclarar antes de cambiar el plato.

| Situación conocida | Qué comprobar | Siguiente paso |
|---|---|---|
| **Boca revisada y cicatrizada** | Come solo y mantiene su consumo habitual. | Organizar alimento y presentación; comunicar cambios nuevos. |
| **Extracción o cirugía reciente** | Instrucciones de alta sobre comida y revisión. | Seguir el plan del centro que lo intervino y aclarar dudas. |

| Situación conocida | Qué comprobar | Siguiente paso |
| --- | --- | --- |
| **Dificultad para tragar, tos o alimento que vuelve** | Qué ocurrió, sin repetir la toma para probar. | Detener el intento y contactar; dificultad respiratoria requiere urgencias. |

## Qué señales cambian la prioridad

Cornell, en su guía de enfermedad dental, incluye dificultad al comer, menor apetito, sangrado, hinchazón y babeo entre los motivos para contactar con el veterinario. Comunica las señales que hayas observado, aunque sea solo una.

El Manual Merck sobre dilatación del esófago explica que la regurgitación puede formar parte de un problema esofágico. Si el alimento vuelve tras ingerirlo, describe cuándo ocurre y solicita valoración antes de cambiar la consistencia.

La guía de neumonía de Merck también describe complicaciones por aspiración y signos respiratorios. Ante tos o dificultad para tragar, detén el intento de alimentación y contacta con el equipo.

### SI RESPIRA CON DIFICULTAD, NECESITA ATENCIÓN URGENTE

Ante respiración trabajosa, empeoramiento respiratorio, colapso o atragantamiento, acude a urgencias. No continúes ensayos de alimento o agua ni retrases la atención para grabar, pesar comida o completar un registro.

Para preparar la revisión de la boca, puedes ampliar la información en nuestra guía de salud dental en perros mayores. Aquí nos centraremos en las decisiones de alimentación que vienen después de aclarar esa situación.

# Elige una base que cubra sus necesidades y entiende su ración

## Completo, complementario y dieta veterinaria

Antes de comparar dureza, busca qué función tiene el producto. La federación de la industria europea FEDIAF distingue alimento completo y complementario: el segundo está pensado para formar solo una parte de la alimentación, no para cubrirla por sí solo.

Que un alimento sea blando, venga en lata o tenga aspecto de carne no responde esa pregunta. Busca la declaración correspondiente en el envase; si no queda clara, consulta al fabricante o lleva una fotografía legible al equipo veterinario.

Una dieta veterinaria tiene una finalidad individual que también debes conocer. Comprueba si está indicada como única comida y durante qué etapa; la adecuación nutricional y la compatibilidad con una enfermedad se valoran juntas.

Las guías de nutrición y control de peso de AAHA de 2021 contemplan esa distinción y los planes personalizados. La indicación profesional debe explicar qué producto usar, para qué y cómo se incorpora al conjunto de la dieta.

## La palabra senior no decide la dieta

La edad es parte de la información, pero el nombre de una gama no explica todo lo que necesita tu perro. Revisa la adecuación del alimento actual antes de sustituirlo solo porque otro envase muestre un perro mayor.

Las preguntas de nutrición de Tufts explican que la lista de ingredientes no describe por sí sola el perfil nutricional. Para comparar, reúne la declaración de adecuación, la energía y las instrucciones del producto.

La aceptación también cuenta: una dieta que deja sistemáticamente en el plato requiere revisar cómo se le ofrece y qué está ocurriendo. Lleva ambas cosas a la consulta: la información del alimento y lo que observas al servirlo.

## Gramos, calorías y volumen no son intercambiables

Los gramos indican peso; las kilocalorías, energía. Una cucharada o un plato lleno describen volumen de manera mucho menos precisa. Para comparar alimentos necesitas conocer qué cantidad del producto representa la información energética, no solo mirar cuánto ocupa.

La guía de selección de alimentos de WSAVA propone comprobar adecuación y contenido calórico. Si este último no aparece en tu etiqueta, puedes pedirlo al fabricante: las formas de declararlo dependen también del mercado.

Lee siempre la unidad completa: por gramo, por cien gramos, por kilogramo o por envase. Antes de hacer una operación, lleva los datos a la misma referencia. Si una cifra resulta confusa, consérvala tal como aparece para aclararla.

Al registrar la alimentación diaria, incluye lo que se utiliza para dar medicación, los premios y otros extras. No necesitan ser grandes porciones para quedar fuera de la memoria. El equipo decidirá cómo encajan; tú puedes facilitar el inventario real.

## Cómo comparar dos etiquetas sin igualar cucharadas

Esta ficha reúne los datos de dos opciones antes de comprarlas o sustituir una por otra. Deja en blanco lo que tengas que consultar al fabricante o a la clínica.

Datos que copiar del producto exacto; A y B no representan marcas.

| Dato | Alimento A | Alimento B |
|---|---|---|
| **Función y adecuación** | Completo o complementario; especie y etapa. | La misma información, comprobada por separado. |
| **Energía** | Cifra y unidad exacta. | Cifra convertida a la misma unidad. |
| **Cantidad indicada** | Producto base y unidad del plan individual. | Nueva cantidad, si la sustitución se autoriza. |
| **Preparación y conservación** | Qué modificaciones admite y cómo guardarlo. | Instrucciones propias, sin copiar las de A. |

**Ejemplo ficticio, solo aritmético; no es una ración recomendada:** A aporta 100 kilocalorías por 100 gramos y B aporta 200 kilocalorías por 100 gramos. En una comparación de 50 gramos, A representaría 50 kilocalorías y B, 100.

La cuenta muestra por qué igual peso puede aportar distinta energía. Para decidir una sustitución, el equipo revisará además los nutrientes y la cantidad que corresponde a tu perro.

## Qué necesitas que te deje escrito la clínica

Conviene salir con una instrucción que otra persona pueda seguir sin interpretaciones: nombre exacto del alimento, cantidad diaria de base, reparto, extras permitidos, adaptación de textura autorizada y momento o motivo para revisar el plan.

Aclara si la cantidad corresponde al producto antes de añadir agua y qué hacer si no acaba una toma. También si hay varias dietas combinadas: «un poco de cada una» no permite reconstruir después lo que recibió.

Pide que cualquier cambio quede anotado en el mismo lugar que la pauta vigente. Así evitas conservar dos instrucciones incompatibles en mensajes distintos y que cada cuidador siga una.



Ilustración generada con IA, sin una ración recomendada: medir el alimento antes de adaptarlo permite distinguir la base del agua añadida.

## Qué presentación puede encajar: húmedo, pienso, triturado o casero

### Húmedo completo: comprueba también su estructura

«Húmedo» describe una familia amplia: puede haber paté uniforme, trozos o partes sólidas acompañadas de salsa. Mira qué tiene que recoger realmente del plato y si deja una parte mientras consume otra; no basta con ver el recipiente vacío de líquido.

Comprueba en la etiqueta si es completo y compatible con su plan. Una vez elegida la base, identifica la estructura concreta que le resulta cómoda: el nombre «húmedo» abarca presentaciones muy distintas.

También importa que la cantidad pautada se pueda preparar y reconocer. Si se reparte un envase entre varias tomas, acuerda cómo medir cada parte y conservar el resto. La elección debe funcionar en la rutina, además de parecer sencilla al comprarla.

## Pienso habitual o adaptado

La posibilidad de comer pienso sin dientes que explica UC Davis permite conservar una dieta conocida cuando encaja con su situación. Revisa el tamaño de las piezas, el estado de la boca y cómo consigue recogerlas y comerlas.

Si el equipo permite humedecer o triturar su alimento habitual, comprueba también las instrucciones del producto. Así adaptas una base ya adecuada conservando su identificación y la cantidad indicada. Una dificultad para tragar necesita valoración propia.

Describe el cambio con palabras concretas: qué producto se modificó y qué aspecto tiene al servirlo. Si alguien más prepara las comidas, mostrarle la presentación acordada resulta más claro que pedirle algo «más blandito» sin una referencia común.

## Una preparación casera necesita formulación

FEDIAF, la federación de la industria europea, explica la complejidad de las dietas caseras y la necesidad de un plan con un profesional de nutrición veterinaria.

Una receta formulada especifica ingredientes, cantidades y suplementos para cubrir sus necesidades. Pregunta cómo modificar su preparación manteniendo esas indicaciones; triturar una mezcla improvisada de pollo, arroz o verduras no la convierte en una dieta completa.

La guía de comida casera para perros mayores desarrolla esa cuestión. Para un perro sin dientes, la pregunta específica es cómo presentar la receta que le corresponde, no cómo inventar otra a partir de alimentos que pueda lamer.

## Compara esfuerzo, cantidad identificable y conservación

El centro canino de Cornell recuerda que la elección senior requiere individualización y que el olor participa en la apetencia. Anota qué presentación acepta y qué parte deja para poder comentarlo.

Explica qué necesitas resolver antes de cambiar producto, textura y añadidos a la vez. La tabla compara el uso cotidiano de las opciones: preparación, cantidad identificable y conservación.

Comprueba también quién puede preparar cada opción y con qué material. Si una presentación exige pasos que no puedes repetir en todas las tomas, plantea esa dificultad antes de sustituirla ocasionalmente por otra comida sin una equivalencia acordada.

Cuatro posibilidades condicionadas a la adecuación y a la situación del perro.

| Presentación | Qué puede facilitar | Qué hay que comprobar |
|---|---|---|
| **Húmedo completo** | Ofrecer una base blanda sin remojar. | Estructura real, cantidad indicada, compatibilidad y conservación tras abrir. |
| **Pienso habitual sin modificar** | Mantener una dieta y preparación conocidas. | Tamaño adecuado, boca recuperada y capacidad individual para comerlo. |
| **Alimento habitual adaptado** | Cambiar la presentación conservando una base identificada. | Adaptación autorizada, textura acordada, higiene y medición antes del añadido. |
| **Receta casera formulada** | Continuar un plan individual con presentación apropiada. | Instrucciones profesionales, ingredientes y cantidades preservados; no improvisar equivalencias. |

## Prepara una comida adaptada sin perder la cuenta de lo que come

### Anota y mide antes de modificar el alimento

Reúne el alimento exacto, el plato, los utensilios limpios y la indicación vigente. La recomendación de un plan escrito de AAHA se vuelve útil aquí: cada preparación debe poder reconocerse después, incluso si varias personas se reparten las tomas.

Si utilizas una báscula, coloca el recipiente vacío y tara antes de añadir el alimento; así la lectura representa el contenido, no el plato. Emplea la unidad de la pauta y confirma cualquier conversión antes de servir.

En una combinación de alimentos, identifica y mide cada componente por separado. Si alguien toma el relevo, podrá seguir la misma preparación y reconstruir qué recibió, en lugar de conocer solo el peso de la mezcla final.

La referencia energética corresponde a una cantidad del producto. Mide esa base antes de añadir agua y registra el añadido aparte: el recipiente final tendrá más volumen, con la misma base alimentaria.

## Cambia la presentación que se haya autorizado

Sigue la adaptación autorizada para ese alimento: deshacer, humedecer o triturar. Si se ha indicado una mezcla blanda uniforme, comprueba con el utensilio que tenga una textura parecida en todo el plato, sin grumos duros ni zonas secas.

Evita que un exceso de líquido separado oculte partes duras o le permita lamer solo el agua [illegible] la base de la referencia es la preparación acordada, con las instrucciones del producto sobre agua y remojo.



Si cuesta tragar, la consistencia se decide con su equipo: el Manual Merck, en su capítulo sobre enfermedad esofágica, explica que varía entre pacientes. No hagas pruebas con mezclas cada vez más líquidas para buscar una que tolere.

Para quien prepare la siguiente toma, anota la modificación con claridad. «Base medida y agua añadida» conserva información que «papilla» pierde. Si hace falta más precisión, acuerda con el equipo una descripción de la textura que todos podáis seguir.

SECUENCIA DIDÁCTICA · CUATRO PASOS

## La base se mide antes de cambiar la presentación

Sigue el recorrido del alimento: añadir agua, cuando esté indicado, cambia su presentación; no añade alimento ni demuestra cuánto acabará comiendo.

01 **Separa la base indicada**

Tara el recipiente vacío y mide la cantidad de alimento que corresponda a su plan. Las porciones dibujadas son símbolos: no representan gramos ni una ración recomendada.

02 **Adapta solo si está permitido**

Traslada esa misma base al recipiente de preparación. Añade agua o modifica la textura únicamente si es apropiado para ese producto y para tu perro; el dibujo no indica una proporción.

03 **Más volumen, la misma base**

La presentación puede ocupar más espacio después de añadir agua. Los mismos símbolos de alimento siguen dentro: el volumen de la mezcla no sustituye a la cantidad de base ni mide absorción.

04 **Ofrece y anota lo que quede**

Sirve sin forzar y observa la tolerancia. Distingue lo servido de lo realmente ingerido; si quedan restos o hay derrames, conserva esa incertidumbre en el registro.

> **Detén el intento ante dificultad para tragar.** Consulta; si respira con dificultad, busca atención urgente. No fuerces comida ni agua.

Solo ilustra la relación entre base y presentación. No es una receta, un cálculo de calorías ni una pauta para problemas de deglución. El tiempo de reproducción solo facilita la lectura; no indica la duración de una preparación o una toma.

## Sirve para que coma por sí mismo

Si recoge la comida con la lengua, un plato llano, ancho y estable deja la superficie accesible sin tener que alcanzar el fondo entre bordes altos. Una base antideslizante ayuda a que permanezca en su sitio mientras come.

Colócalo en un lugar tranquilo y accesible. Observa si llega a la comida por sí mismo y deja que coma voluntariamente, sin sujetarle la cabeza. La altura y cualquier postura especial deben respetar sus indicaciones individuales.

Mantén el acceso al agua conforme a su plan y anota por separado la que añadas al alimento. Si tiene restricciones de líquidos, pide que la preparación también quede contemplada en ellas.

El Manual Merck sobre neumonía relaciona la alimentación forzada con riesgo de aspiración. Si necesita ayuda especial para alimentarse, requiere una indicación y formación individuales.

### NO INTRODUZCAS COMIDA O AGUA A LA FUERZA

No uses una jeringa para forzar la alimentación ni abras su boca para introducir comida. Si no consigue alimentarse, contacta con su equipo. Ante tos o dificultad para tragar, detén el intento; ante dificultad respiratoria, necesita urgencias.

## Revisa lo que quedó antes de dar la toma por terminada

Anota el alimento ofrecido y lo que puedes estimar que ha quedado. Si el contenido era uniforme, conoces toda la preparación y no hubo derrames, indica la proporción restante como una estimación.

Si lamió solo la salsa, seleccionó trozos o parte de la comida acabó en el suelo, no conviertas «medio plato» en una cifra exacta de energía. El dato útil puede ser precisamente que no pudiste reconstruir lo ingerido.

Reserva material limpio para servir y medir, distinto del comedero utilizado. Al terminar, retira los sobrantes y lava el plato; el apartado de conservación explica cómo organizar la comida que aún está guardada.



Ilustración generada con IA. Comprueba que la textura coincida con la adaptación indicada y conserva la medida de alimento base.

## Después de una extracción: sigue un plan de cicatrización propio

### Qué debe contener el alta

La alimentación temporal después de una extracción forma parte de la recuperación. El alta debe explicar qué cambia respecto de su dieta habitual y quién decidirá cuándo volver a la presentación anterior.

VCA y LifeLearn, en su información sobre cirugía oral, señalan que suele indicarse alimento blando durante la cicatrización y que las revisiones comprueban su evolución. Esa orientación general no fija el plan ni la duración para tu perro.

Al recogerlo, confirma qué alimento ofrecer, cómo presentarlo, qué cantidad y reparto seguir y qué hacer si no come como se esperaba. Si el documento solo dice «blando», pide una explicación que puedas llevar a la cocina sin adivinar.

## Concreta qué significa «comida blanda»

Pide una descripción concreta: producto, textura final y modificaciones permitidas. Si el alimento trae trozos y salsa, pregunta si debes deshacerlo o utilizar otra presentación. «Blando» puede necesitar esa aclaración para que todos preparen lo mismo.

La vuelta al pienso depende de la intervención y de la revisión de su boca, no del calendario de otro perro. Conserva la indicación temporal hasta que el centro confirme el siguiente cambio.

Conserva junto al alta el nombre de la dieta que utilizaba antes de operar. Si había una indicación por otra enfermedad, pregunta cómo mantener ese objetivo durante la recuperación.

## Cuándo volver a hablar con el centro

Comunica dificultades para comer o beber, molestias, sangrado o cualquier cambio que no encaje con lo explicado al alta. Describe qué estaba haciendo y qué cantidad pudo tomar, sin intentar revisar puntos o heridas abriéndole la boca.

La guía dental de Brian Collins, de Cornell, sitúa la vuelta a los cuidados domésticos bajo las recomendaciones del veterinario tras la recuperación. Mantén suspendido cualquier cuidado sobre la zona que el centro haya restringido, incluido el cepillado.

Si se aparta del plato o interrumpe las tomas, cuéntalo al centro junto con la cantidad que está tomando y la preparación que sigues. Esa información ayuda a revisar comodidad, recuperación y alimentación.

## Coordina a quienes lo cuidan

Elige un lugar común para el alta y las anotaciones. Quien da la comida puede registrar la hora, qué preparación siguió y qué quedó; quien toma el relevo ve esos datos sin depender de una conversación recordada a medias.

Si el centro cambia una indicación, señala desde cuándo se aplica y cuál sustituye. Esto evita que una persona prepare la textura anterior mientras otra empieza con la nueva, sin que nadie pueda explicar después qué tomó realmente.

Mantén los medicamentos en su pauta específica, sin añadir, suspender o cambiar dosis para facilitar una comida. Cuando administrarlos sea difícil, consulta al centro; no presupongas que se pueden triturar o mezclar con cualquier alimento.

Una hoja compartida con la pauta vigente, las tomas y el contacto del centro facilita los relevos. Señala quién dio la última comida y cualquier dificultad que deba conocer la siguiente persona.

## Conserva las preparaciones blandas y humedecidas

### Prepara con material limpio

Lava las manos antes y después de preparar la comida, y los platos y utensilios después de usarlos, como aconseja la FDA sobre manipulación segura. Utiliza una cuchara limpia para sacar alimento del envase y mantenla separada del comedero usado.

Si preparas varias tomas según sus instrucciones, identifica el producto y cuándo lo abriste o modificaste. Distingue la comida guardada de la que ya serviste. Las sobras del plato se retiran aparte, en lugar de devolverlas al envase.

### Guarda según el producto y su preparación

La FDA, en su guía de conservación, indica refrigerar pronto o desechar los sobrantes de lata o bolsa húmeda y cubrirlos al refrigerar. Sigue también las condiciones y plazos del fabricante para ese producto.

Para pienso humedecido, triturados o recetas caseras, confirma cómo conservar la preparación concreta. La referencia de una lata abierta no establece cuánto dura una mezcla diferente. Hasta aclararlo, evita preparar grandes cantidades para varios días.

Conserva el envase original, el lote y la caducidad. Si utilizas un recipiente exterior para la bolsa, mantenlo limpio y seco; lávalo y sécalo al cambiar de bolsa. Así quedan disponibles los datos que necesitas si surge alguna incidencia.

### Aparta lo sospechoso y resuelve los sobrantes

Ante un envase hinchado o con fugas, olor anómalo, un cuerpo extraño o una sospecha relacionada con el alimento, deja de utilizarlo y conserva sus datos para consultar. Si el perro presenta síntomas, contacta con el equipo veterinario.

Al recoger la cocina, comprueba cuatro cosas: sobrantes retirados o conservados según las instrucciones, envase identificado, material lavado y siguiente toma distinguible. Esa rutina facilita repetir la preparación sin confundir comida guardada, recién preparada y ya servida.

## Si además tiene otra enfermedad o empieza a comer menos

### Una necesidad dental no borra las otras

Si su dieta se eligió por una enfermedad, ese objetivo sigue existiendo cuando pierde dientes. El cambio debe contemplar ambos problemas. Las guías de nutrición de AAHA incluyen las enfermedades concurrentes entre los factores que modifican una recomendación alimentaria.

La conversación puede empezar con una pregunta concreta: «¿Podemos adaptar la presentación del alimento que ya tiene indicado o necesita una alternativa?». Si hay que sustituirlo, pide producto, cantidad, reparto y seguimiento; no basta con buscar otro que parezca igual de blando.

Aclara también qué hacer con los alimentos que acompañan la medicación y los extras habituales. Llevar la lista completa permite revisar su aportación dentro del plan,

especialmente si tiene restricciones o combina varios productos.

## Sobrepeso y pérdida de músculo pueden coexistir

Cornell explica al hablar de alimentación senior que la condición corporal y la muscular se valoran por separado. Reúne las observaciones de ambas con las medidas de peso para que la revisión contemple el conjunto.

Si notas cambios de peso o musculatura, comunícalos antes de ajustar la cantidad o añadir suplementos. El chequeo geriátrico canino ayuda a preparar esa valoración más amplia.

Si el equipo solicita controlar el peso, acuerda cómo hacerlo de manera segura y comparable. Anota fecha, cifra y condiciones de medida. No fuerces a un perro inseguro a subir a una báscula doméstica para completar una casilla.

En la revisión, combina esa tendencia con los datos de consumo y los cambios de salud. Así el equipo puede valorar si hace falta ajustar alimento, cantidad o seguimiento.

## Cuando se acerca al plato pero no termina

Distingue interés de consumo. Puede acercarse, oler, recoger una parte y marcharse; decir que «tenía hambre» no cuenta cuánto recibió. Describe la secuencia y qué quedó, especialmente si el comportamiento difiere del que ya conocías.

Ordena qué cambió: producto, presentación, forma de servir, rutina o medicación indicada. Señala qué sabes y qué queda por aclarar. Preferir una comida aporta información sobre aceptación, pero no identifica la causa de un rechazo previo.

Si utiliza una receta profesional, consulta alternativas dentro de esa formulación. Lleva la lista de ingredientes que está aceptando y de los que deja: permite revisar tanto la comodidad al comer como lo que realmente está recibiendo.

## Cuando no logra cubrir su alimentación

Contacta con el equipo si no consigue comer suficiente o su consumo se reduce. No esperes a que la dificultad se resuelva probando todos los formatos, ni utilices el registro para aplazar la consulta hasta reunir una serie perfecta.

Las FAQ de nutrición de Tufts explican que el soporte mediante sondas puede formar parte de la atención cuando un animal no puede o no quiere ingerir lo necesario. Es una opción veterinaria que requiere valoración y formación específicas.

Si la alimentación voluntaria resulta insuficiente, pregunta qué alternativas hay, qué objetivo tienen y cómo se revisarán. La decisión reúne síntomas, evolución y bienestar; un rechazo aislado no basta para tomar decisiones de final de vida.

## Registra lo que ocurre y lleva una pregunta concreta a la revisión

### Qué anotar sin convertir la casa en una consulta

Empieza por fecha, persona cuidadora, nombre exacto del alimento, base ofrecida y preparación. Añade lo que observaste durante la toma: con esos datos otra persona podrá reconstruir qué ocurrió y continuar el cuidado.

AAHA incluye historia dietética y seguimiento en sus guías de nutrición. Para llevarlo a la práctica, diferencia la cantidad servida de la consumida e identifica otros alimentos. Puedes usar las mismas palabras y unidades entre cuidadores para facilitar la lectura.

Anota sobrantes, derrames y selección de ingredientes si ocurrieron. En observaciones, describe acciones como dejar caer comida o apartarse; añade cuándo sucedieron. Evita resumir todo con «bien» o «mal», porque otra persona no sabrá qué significa esa valoración.

Anota el peso en las fechas y condiciones acordadas, si puede medirse sin riesgo. Para las tomas diarias, céntrate en el alimento y el consumo; reserva la báscula corporal para el seguimiento que os hayan indicado.



Ilustración generada con IA, no seguimiento de un paciente. Observar una toma permite describir lo que ocurre, sin deducir un diagnóstico de la escena.

## Lo medido, lo estimado y lo desconocido

**Ejemplo ficticio de cálculo, no una ración:** se ofrecen 40 gramos de un único alimento sin añadir agua y quedan 10 gramos recuperables, sin derrames ni otra fuente de comida. La diferencia observada es 30 gramos.

La resta deja de describir lo mismo si parte acabó en la alfombrilla o quedó adherida al utensilio. En ese caso, indica qué no pudiste medir. No conviertas por comodidad todo lo que desapareció del plato en alimento ingerido.

Si añadiste agua, conserva la cantidad inicial de base y anota esa modificación aparte. Restar gramos de una mezcla final a gramos del alimento original mezcla referencias distintas. Una estimación de proporciones exige conocer y reconocer la preparación, no solo pesar el recipiente.

Cuando no haya una estimación razonable, escribe «cantidad no determinada» y explica por qué: selección de partes, derrame o preparación desconocida. Esa explicación permite acordar cómo medir mejor una toma posterior.

SECUENCIA DIDÁCTICA · CUATRO PASOS

## Del plato al registro: qué sabemos y qué estimamos

Que falte alimento del plato no prueba por sí solo que se haya ingerido todo. La secuencia separa observaciones y dudas antes de llevarlas a la consulta.

01

### Identifica lo que ofreciste

Anota el producto y la cantidad de alimento base con su unidad. Separa el agua de preparación y los extras. Los símbolos no son una cantidad recomendada ni un ejemplo de consumo medido.

02

### Separa sobrante y derrame

Lo que queda en el plato y lo que cae fuera son observaciones distintas. Si no puedes medirlos o la mezcla no es homogénea, no conviertas lo que falta en una cifra exacta de ingesta.

03

### Distingue medido, estimado y desconocido

Conserva la unidad y la calidad del dato. Una impresión puede anotarse como estimación; una cantidad que no pudiste comprobar sigue siendo desconocida. No hace falta inventar un número para completar una casilla.

04

### Traslada datos y preguntas

Copia al registro lo ofrecido, los restos, la incertidumbre y los signos observados. Llévalo junto al envase y a tus preguntas. El registro ayuda a explicar lo ocurrido; no determina la causa ni ajusta una dieta.

> **Detén el intento ante dificultad para tragar.** Consulta; si respira con dificultad, busca atención urgente. No fuerces comida ni agua.

Esquema de observación, no una prueba diagnóstica. No provoques otra toma para grabar síntomas ni retrases atención por completar los datos. El tiempo de reproducción solo facilita la lectura; no indica la duración de una preparación o una toma.

## Compara observaciones sin atribuir causas

Anota cuándo cambió la preparación y qué ocurrió después: cantidad ofrecida, sobrantes y comportamiento. Esa secuencia ayuda a comparar las tomas; por sí sola no identifica la causa del cambio.

Si el consumo parece disminuir, explica en qué te basas: más sobrantes del mismo producto, tomas interrumpidas o una cantidad que ya no puedes reconstruir. Si también cambió el alimento, señala los gramos y los datos de energía de cada producto.

Conserva la identificación del envase y una fotografía de la etiqueta. Si utilizas un producto distinto, señala la fecha y el nombre exacto en el registro para que esa diferencia quede visible al revisar las tomas.

## Prepara una consulta que resuelva algo

Lleva las instrucciones vigentes, el registro y el envase o una fotografía legible. Si hubo cirugía, añade el alta. Selecciona los cambios importantes y señala qué datos son inciertos para que la conversación empiece por lo que necesitáis resolver.

AAHA señala que un vídeo de una conducta alimentaria inusual puede ayudar a evaluarla. Solo graba si ocurre espontáneamente y hacerlo es seguro; no provoques la dificultad, repitas la toma o retrases atención para obtener una grabación más clara.

Formula una pregunta que pueda concretarse: «¿Esta dieta sigue siendo adecuada?», «¿La presentación que preparo coincide con lo indicado?» o «¿Qué cantidad debo registrar antes de añadir agua?». Llevar dudas específicas ayuda a cerrar instrucciones que antes quedaban ambiguas.

Al terminar, confirma qué observar, qué cambios comunicar y cómo contactar si vuelve a comer menos. Deja las respuestas junto al registro para que todas las personas cuidadoras sepan cuál es el siguiente paso.

UNA TOMA · DATOS PARA COMPARTIR

### Registro de alimento y tolerancia

Completa los campos o imprímelos en blanco. No se guardan ni se envían: copia o imprime lo que quieras conservar antes de cerrar o recargar la página.

**Fecha y hora**

**Persona cuidadora**

**Producto exacto / envase**

**Base ofrecida: cantidad y unidad**

**Presentación / agua añadida, si procede**

**Sobrante y derrame: cantidad o descripción**

**Qué fue medido, estimado o desconocido**

**Otros alimentos o extras**

**Qué ocurrió durante o después de comer y cuándo (máximo 300 caracteres)**

**Preguntas e indicaciones para la revisión (máximo 220 caracteres)**

Los campos cortos admiten entre 80 y 120 caracteres. Usa la misma unidad para comparar la base ofrecida y el sobrante. Si no puedes medir algo, escribe «estimado» o «desconocido», sin inventar precisión.

> **No esperes a completar el registro si empeora.** Dificultad respiratoria: atención urgente. Este registro no interpreta síntomas ni prescribe alimento.



Ilustración generada con IA; no representa una visita clínica real. Llevar observaciones concretas permite plantear preguntas sobre su alimentación.

## Conclusión

Alimentar a un perro mayor sin dientes empieza por conocer su situación, no por escoger la papilla más fina. Una boca cicatrizada, una recuperación quirúrgica y una dificultad para tragar necesitan decisiones distintas, aunque desde fuera todas parezcan un problema ante el plato.

La rutina puede ser sencilla: identificar una dieta adecuada, conocer su cantidad antes de adaptarla y comprobar qué consigue comer. Mantener claras esas referencias ayuda a compartir el cuidado sin confundir volumen, apetencia y aporte nutricional.

Si la toma no resulta tolerable o el consumo cambia, explica lo que ocurre y pide revisar el plan. No necesitas demostrar una causa ni agotar opciones en casa para que la consulta esté justificada.

Puedes seguir explorando nuestras guías de alimentación de perros senior para organizar su cuidado diario y preparar las preguntas de la próxima revisión.

## FUENTES CIENTÍFICAS Y DE AUTORIDAD

Estas fuentes respaldan conceptos y límites de la guía. Son documentos institucionales y guías clínicas generales; no un ensayo de una receta o textura universal para perros mayores desdentados.


- **UC Davis:** Dentistry and Oral Surgery Service, FAQ sobre alimentación sin dientes. Actualización de página: 9 de octubre de 2026.
- **AAHA:** Dentistry — 2023 AAHA Senior Care Guidelines, dificultades al comer y evaluación oral. Página publicada el 13 de diciembre de 2022.
- **Martha G. Cline y colaboradores / AAHA:** 2021 AAHA Nutrition and Weight Management Guidelines for Dogs and Cats, evaluación, planes y seguimiento.
- **WSAVA Global Nutrition Committee:** Guidelines on Selecting Pet Foods, adecuación y energía; actualización de 2021.
- **FEDIAF:** Nutritional needs of cats and dogs, distinción completo/complementario. Federación de la industria europea.
- **Alice Defarges / Merck Veterinary Manual:** Dilatation of the Esophagus in Small Animals, consistencia individual y enfermedad esofágica. Revisión: octubre de 2022; actualización: mayo de 2025.
- **Ned F. Kuehn / Merck Veterinary Manual:** Pneumonia in Dogs, aspiración y signos respiratorios. Revisión: junio de 2018; actualización: septiembre de 2024.
- **Courtney Barnes, Lorraine Hiscox y Jan Bellows / VCA–LifeLearn:** Oral Surgery in Dogs, alimentación durante cicatrización y revisiones. Actualización: 26 de abril de 2024.
- **FDA:** Tips for Safe Handling of Pet Food and Treats, manipulación e higiene.
- **FDA:** Proper Storage of Pet Food & Treats, conservación e identificación del producto.
- **Tufts University Cummings School:** Nutrition FAQs, lectura de ingredientes y soporte nutricional profesional.
- **Cornell University Riney Canine Health Center:** Choosing food for your senior dog, individualización, condición y apetencia.
- **Brian Collins / Cornell University:** Dental disease and home dental care, signos para consultar y cuidados tras recuperación.
- **FEDIAF:** Home Made Diets, formulación de dietas caseras. Federación de la industria europea.


La responsabilidad editorial corresponde al equipo del sitio; no se acredita revisión veterinaria individual de este artículo. Esta información no sustituye la evaluación de tu perro ni las instrucciones de su centro veterinario.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede comer pienso un perro que ya no tiene dientes?

¿Una papilla casera sustituye a un alimento completo?

¿Cómo sé cuánto ha comido si añadí agua?

¿Puedo triturar la dieta veterinaria que ya toma?

¿Durante cuánto tiempo necesita blando tras extraer dientes?

¿Sirven los caldos o complementos como comida principal?

¿Qué hago si quiere comer pero deja caer la comida o tose?

¿Tengo que cambiar a un alimento senior por su edad?

## ¿Te ha resultado útil esta guía?

Tu valoración nos ayuda a mejorar y a priorizar el contenido especializado.

Sí, me sirvió | No del todo

## Más guías de Alimentación de perros senior

### Comida casera para perros mayores: cómo planificar una dieta segura

Comida casera para perros mayores: formulación individual, textura, higiene y señales de alarma an…

**Leer: Comida casera para perros mayores: cómo planificar una dieta segura** →

**Cuida tu Perro Viejo**

Información clara y herramientas prácticas para acompañar con más confianza los años senior de tu perro.

EXPLORAR

- Guías por tema
- Herramientas
- Calculadora de edad
- Asistente IA

INFORMACIÓN

- Sobre nosotros
- Política editorial
- Contacto
- Privacidad
- Cookies

© 2026 Cuida tu Perro Viejo. Todos los derechos reservados.

La información del sitio no sustituye una consulta veterinaria.